

Grille d'évaluation ECOS - USMLE-15 - Aménorrhée - Femme de 36 ans

Cabinet médical

Patricia Garrison, 36 ans, vient au cabinet en se plaignant de l'absence récente de menstruations

TA
120/85 mmHg

FC
65 bpm

FR
13/min

T°
36.7°C

Anamnèse (25%)

Score : 0/47

Critères	Oui	±	Non	Points
1. Motif principal [Je n'ai pas eu de règles depuis 3 mois]	☐		☐	0
2. Histoire menstruelle				0
Cycles récents [J'avais des règles régulières tous les mois durant 4-5 jours, mais au cours de l'année écoulée, elles sont devenues moins fréquentes (tous les 5-6 semaines, durant 7 jours)]	☐			
Flux menstruel [C'était 2-3 serviettes par jour, mais le flux sanguin devient de moins en moins abondant, et je n'utilise maintenant qu'une seule par jour]	☐			
Ménarche [14 ans]	☐			
Dernier frottis [Il y a dix mois. C'était normal]	☐			
ATCD frottis anormaux [Non]	☐			
3. Changements physiques récents				0
Prise de poids [J'ai pris presque 7 kg au cours de l'année écoulée]	☐			
Pilosité anormale [En fait, j'ai récemment remarqué des poils sur mon menton que j'ai dû épiler]	☐			
Changement de voix [Non]	☐			
Changements peau/cheveux [Non, à part les poils du menton]	☐			
Écoulement mamelonnaire [Oui, juste la semaine dernière, j'ai remarqué un écoulement lactescent de mon sein gauche]	☐			
4. Symptômes associés				0
Intolérance au froid [Non]	☐			
Transit intestinal [Non, pas de changement]	☐			
Appétit [J'ai un bon appétit]	☐			
Fatigue [Non]	☐			
Dépression/anxiété/stress [Non]	☐			
Bouffées de chaleur [Non]	☐			
Sécheresse/prurit vaginal [Non]	☐			
Problèmes de sommeil [Non]	☐			
Fréquence urinaire [Non]	☐			
5. Symptômes neurologiques				0
Changements visuels [Non]	☐			
Céphalées [Non]	☐			
Douleur abdominale [Non]	☐			
6. Histoire gynécologique et sexuelle				0
Activité sexuelle [Environ une fois par semaine avec mon mari]	☐			
Contraception [Les mêmes pilules contraceptives depuis 8 ans]	☐			
Grossesses [J'ai un enfant ; il a 10 ans]	☐			
Complications grossesse [Non, c'était un accouchement normal, et mon enfant est en bonne santé]	☐			
Fausses couches/IVG [Non]	☐			

7. Mode de vie et habitudes

0

Régime alimentaire [Non, je suis végétarienne depuis 10 ans]

☐

Pilules amaigrissantes [Non]

☐

Exercice physique [Je cours 3,2 km trois fois par semaine]

☐

Alcool [Non]

☐

Tabagisme [Non]

☐

Drogues illicites [Jamais]

☐

8. Antécédents médicaux [Aucun]

☐☐

0

9. Antécédents chirurgicaux [Aucun]

☐☐

0

10. Médicaments actuels [Aucun]

☐☐

0

11. Antécédents familiaux [Mon père et ma mère sont en bonne santé ; ma mère a commencé la ménopause à 55 ans]

☐☐

0

12. Profession [Infirmière]

☐☐

0

13. Allergies médicamenteuses [Non]

☐☐

0

Examen clinique (25%)

Score : 0/16

Critères	Oui	±	Non	Points
1. État général [La patiente ne semble pas en détresse aiguë]	☐		☐	0
2. Examen du cou Thyroïde [Pas de thyromégalie]	☐	☐	☐	0
3. Examen cardiovasculaire Auscultation [RR et FC normaux, B1/B2 normaux, pas de souffles, frottements ou galops]	☐	☐	☐	0
4. Examen pulmonaire Auscultation [Murmures vésiculaires clairs bilatéralement]	☐	☐	☐	0
5. Examen abdominal				0
Inspection [Normal]	☐			
Auscultation [Bruits intestinaux normaux en quantité et qualité]	☐			
Palpation [Détendu, souple et indolore, pas d'hépatosplénomégalie]	☐			
6. Examen des extrémités Inspection [Pas d'œdème, pas de tremblement]	☐	☐	☐	0
7. Examen neurologique				0
Champs visuels [Complets à la confrontation]	☐			
Mouvements oculaires [Normaux sans diplopie ni rétraction palpébrale]	☐			
ROT [Normaux dans les membres inférieurs ddc]	☐			

Management (25%)

Score : 0/29

Critères	Oui	±	Non	Points
----------	-----	---	-----	--------

1. Hypothèses diagnostiques

2 points si au moins 2 diagnostics pertinents mentionnés, 1 point si 1 diagnostic



0

Diagnostics différentiels à considérer

Causes les plus probables

• Grossesse → Test hCG urinaire ou sanguin

Arguments POUR:

- ☐ Aménorrhée secondaire de 3 mois
- ☐ Femme en âge de procréer
- ☐ Activité sexuelle régulière
- ☐ Sous contraception orale (possible oubli)
- ☐ Écoulement mamelonnaire
- ☐ Antécédent de grossesse réussie

Arguments CONTRE:

- ☐ Contraception depuis 8 ans
- ☐ Oligoménorrhée progressive

• Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) → US pelvienne, testostérone, LH/FSH

Arguments POUR:

- ☐ Oligoménorrhée progressive
- ☐ Hirsutisme (poils au menton)
- ☐ Prise de poids 7 kg
- ☐ Âge compatible (36 ans)
- ☐ Hypoménorrhée (flux diminué)

Critères Rotterdam (2/3):

- ☐ Oligoanovulation
- ☐ Hyperandrogénie clinique

• Hyperprolactinémie → Prolactinémie, IRM hypophysaire si élevée

Arguments POUR:

- ☐ Galactorrhée unilatérale
- ☐ Aménorrhée secondaire
- ☐ Oligoménorrhée progressive
- ☐ Pas de symptômes visuels (microadénome)

Causes possibles:

- ☐ Prolactinome
- ☐ Médicaments
- ☐ Hypothyroïdie

Causes endocriniennes

• Hypothyroïdie → TSH, T4 libre

Arguments POUR:

- ☐ Galactorrhée (hyperprolactinémie secondaire)
- ☐ Prise de poids
- ☐ Oligoménorrhée

Arguments CONTRE:

- ☐ Pas d'intolérance au froid
- ☐ Pas de fatigue
- ☐ Pas de constipation
- ☐ Pas de bradycardie

• Hyperthyroïdie → TSH, T4 libre

Arguments POUR:

- ☐ Oligoménorrhée possible

Arguments CONTRE:

- ☐ Prise de poids (attendrait perte)
- ☐ FC normale (65 bpm)
- ☐ Pas de tremblements
- ☐ Pas de thermophobie

Autres causes

• Insuffisance ovarienne prématurée → FSH, œstradiol, AMH

Arguments POUR:

- ☐ Âge < 40 ans
- ☐ Aménorrhée secondaire

Arguments CONTRE:

- ☐ Pas de bouffées de chaleur
- ☐ Pas de sécheresse vaginale
- ☐ Pas de symptômes climatiques
- ☐ ATCD familial ménopause à 55 ans

• Syndrome d'Asherman → Hystérocopie, hystérosalpingographie

Arguments POUR:

- ☐ Antécédent obstétrical

Arguments CONTRE:

- ☐ Accouchement normal il y a 10 ans
- ☐ Pas de curetage
- ☐ Pas d'infection utérine
- ☐ Oligoménorrhée progressive

2. Examens complémentaires urgents

0

Test de grossesse (hCG urinaire ou sanguin)	☐
Prolactinémie	☐
TSH, T4 libre	☐
FSH, LH, œstradiol	☐
Testostérone totale et libre	☐
DHEA-S, 17-OH progestérone	☐

3. Examens complémentaires selon résultats

0

US pelvienne transvaginale (ovaires polykystiques)	☐
IRM hypophysaire si prolactine > 100 ng/mL	☐
Test de provocation progestérone	☐
Glycémie à jeun, HbA1c (SOPK)	☐
Bilan lipidique (syndrome métabolique)	☐
AMH (réserve ovarienne)	☐

4. Prise en charge selon étiologie

☐ ☐ ☐

0

Si SOPK confirmé

- Perte de poids (objectif 5-10%)
- Metformine 500mg x2/j si surpoids
- Contraception si pas désir grossesse
- Spironolactone 50-100mg/j pour hirsutisme
- Surveillance syndrome métabolique
- Conseil fertilité si désir grossesse

Si hyperprolactinémie

- Microadénome : cabergoline 0.5mg/sem
- Alternative : bromocriptine 2.5mg x2/j
- Surveillance prolactine mensuelle
- IRM contrôle à 6 mois
- Contraception efficace initialement
- Arrêt traitement possible si grossesse

Si hypothyroïdie

- Lévothyroxine selon TSH
- Débuter 25-50 µg/j
- Contrôle TSH à 6 semaines
- Ajustement progressif
- Normalisation cycles avec traitement

5. Examens gynécologiques complémentaires

0

Examen pelvien complet	☐
Examen mammaire bilatéral	☐
Test de galactorrhée provoquée	☐
Évaluation muqueuse vaginale (imprégnation œstrogénique)	☐
Recherche clitoromégalie (hyperandrogénie)	☐

6. Conseils et suivi

0

Journal menstruel prospectif	☐
Maintien poids santé	☐
Activité physique régulière	☐
Gestion du stress	☐
Contraception efficace si pas désir grossesse	☐
Consultation fertilité si désir grossesse > 6 mois	☐

⚠ Red Flags - Urgences endocriniennes

1. **Troubles visuels**
→ Hémianopsie bitemporale = Macroadénome hypophysaire, IRM urgente
2. **Céphalées sévères + troubles visuels**
→ Apoplexie hypophysaire = Urgence neurochirurgicale
3. **Virilisation rapide**
→ Tumeur ovarienne/surrénalienne = CT/IRM urgent
4. **Galactorrhée + grossesse**
→ Risque expansion adénome = Suivi spécialisé
5. **Signes d'hypercortisolisme**
→ Cushing = Bilan endocrinien urgent

Clôture de consultation**Clôture type**

Madame Garrison, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas avoir de règles régulières. La première chose à faire est de déterminer si vous êtes enceinte. Nous pouvons le faire avec un simple test urinaire. L'autre chose à faire est de procéder à des examens pelvien et mammaire, surtout parce que vous avez eu un écoulement mamelonnaire, et de rechercher tout signe de ménopause. La ménopause est très improbable à votre âge, mais dans de rares cas, cela peut arriver. Une prise de sang pour mesurer vos niveaux hormonaux nous aidera également à déterminer si vous êtes ménopausée ou si vous avez un déséquilibre hormonal. Cela nous donnera une bonne base pour comprendre pourquoi vous n'avez pas vos règles, et nous pourrons avancer à partir de là. Avez-vous des questions pour moi ?

Questions difficiles à poser

[Suis-je en train de vivre la ménopause ?]

Réponse type du candidat

J'en doute. Ce serait extrêmement inhabituel à votre âge. J'ai besoin d'en savoir plus en vous posant des questions sur d'autres symptômes et en réalisant un examen. Ensuite, nous pourrons discuter des raisons possibles pour lesquelles vous n'avez plus vos règles.

Communication (25%)

Score : 0/20

Critères

1. Réponse aux sentiments et besoins du patient

Empathie, écoute active, validation des émotions
Explique le déroulement de la consultation et vérifie les préoccupations du patient, commence l'anamnèse par une question ouverte ; reconnaît, verbalise et légitime les émotions, fournit du soutien

2. Structure de l'entretien

Organisation logique, transitions fluides, gestion du temps
Se présente par son nom et sa fonction, les étapes de l'entretien sont identifiables et s'enchaînent de manière logique, gestion du temps, adaptation à la situation

3. Expression verbale

Clarté, vocabulaire adapté, vérification de la compréhension
Langage adapté au niveau du patient, pas de jargon, explications compréhensibles, reformulations quand nécessaire, répétitions des points clés, fait une synthèse de la consultation, bonne articulation, ton et volume adéquats

4. Expression non verbale

Contact visuel, posture, gestuelle appropriée
Distance interpersonnelle adéquate, posture adéquate, gestes adéquats, contact visuel et expression faciale adéquats, pauses quand nécessaire

5. Évaluation générale de la communication

Qualité globale de l'interaction médecin-patient

A

B

C

D

E

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Score Global

0%

% par Section

Anamnèse

0%

Examen clinique

0%

Management

0%

Communication

0%

Note Globale

A-E

Échelle de notation

A

≥90%

B

80-89%

C

70-79%

D

60-69%

E

<60%

Scénario pour la patiente standardisée

Nom : Patricia Garrison | **Âge :** 36 ans

Contexte : Femme mariée avec un enfant de 10 ans, infirmière

Motif de consultation

Plainte principale : «Je n'ai pas eu de règles depuis 3 mois.»

Si on demande s'il y a autre chose : «Mes règles sont devenues irrégulières cette année.»

Consignes

- Paraître légèrement inquiète mais calme.
- Toucher discrètement votre menton en mentionnant les poils.
- Montrer une certaine gêne en parlant de l'écoulement mammaire.
- Être coopérative et donner des réponses claires.
- Exprimer de l'inquiétude sur une ménopause précoce.

Histoire actuelle

cyclesMenstruels :

- Règles régulières jusqu'à l'année dernière
- Maintenant tous les 5-6 semaines
- Durée passée de 4-5 à 7 jours
- Flux très diminué (1 serviette/jour)
- Dernières règles il y a 3 mois

changementsPhysiques :

- Prise de poids 7 kg en un an
- Poils au menton récents
- Écoulement sein gauche la semaine dernière
- Pas d'autres changements

Symptômes négatifs :

- Pas de bouffées de chaleur
- Pas de sécheresse vaginale
- Pas de fatigue
- Pas d'intolérance au froid
- Pas de troubles visuels

Habitudes

- **Alimentation :** Végétarienne depuis 10 ans
- **Exercice physique :** Course 3,2 km x3/semaine
- **Toxiques :** Aucun (ni tabac, ni alcool, ni drogues)
- **Sexualité :** Active avec mari 1x/semaine

Antécédents

Antécédents gynécologiques :

- Ménarche à 14 ans
- G1P1 accouchement normal il y a 10 ans
- Contraception orale depuis 8 ans
- Dernier frottis normal il y a 10 mois

Antécédents médicaux : Aucun

Antécédents familiaux :

- Parents en bonne santé
- Mère ménopausée à 55 ans

Simulation

Durant l'entretien :

- Posture détendue
- Contact visuel maintenu
- Réponses réfléchies
- Légère inquiétude sur ménopause

Durant le status :

- Coopération totale
- Pas de signes d'hirsutisme évidents
- Permettre tous les examens
- Thyroïde non palpable

Informations de l'expert

Dossier médical de l'entretien

Femme de 36 ans avec aménorrhée secondaire de 3 mois sur fond d'oligoménorrhée progressive, hirsutisme débutant, prise de poids et galactorrhée. Tableau évocateur de SOPK avec possible hyperprolactinémie associée. Nécessite exclusion grossesse et bilan hormonal complet.

Rôles et interventions de l'expert·e

L'expert·e intervient si l'étudiant·e demande :

- Test grossesse : négatif
- Prolactine : 85 ng/mL (N: < 25)
- TSH : 2.5 mUI/L (normale)
- LH/FSH : rapport 2.5 (élevé)
- Testostérone : légèrement élevée
- US pelvienne : ovaires polykystiques bilatéraux

Points clés

- SOPK = diagnostic clinique (critères Rotterdam)
- Hyperprolactinémie modérée peut être secondaire au SOPK
- Exclusion grossesse obligatoire
- Risque métabolique à long terme
- Conseil préconceptionnel si désir grossesse

Pièges

- Oublier test de grossesse
- Ne pas examiner seins/pelvis
- Méconnaître association SOPK-prolactine
- Négliger risque cardiovasculaire
- Promettre fertilité spontanée

Diagnostic

Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) avec hyperprolactinémie secondaire probable, sur terrain d'aménorrhée secondaire et signes d'hyperandrogénie clinique débutante

Épidémiologie du SOPK

Endocrinopathie la plus fréquente :

- Prévalence : 6-10% femmes en âge de procréer
- Première cause d'infertilité anovulatoire
- Composante génétique : 40% si mère atteinte
- Association syndrome métabolique : 40-50%
- Risque diabète type 2 : x3-7
- Manifestation variable selon ethnies

Critères diagnostiques Rotterdam 2003

2 critères sur 3 nécessaires :

- Oligo/anovulation (< 9 cycles/an)
- Hyperandrogénie clinique et/ou biologique
- Ovaires polykystiques à l'échographie
- Après exclusion autres causes
- Phénotypes : classique, ovulatoire, normoandrogénic
- Sévérité variable selon phénotype

Physiopathologie

Mécanismes multifactoriels :

- Dysrégulation axe hypothalamo-hypophysaire
- ↑ Pulsatilité GnRH → ↑ LH/FSH
- Hyperandrogénie ovarienne et surrénalienne
- Insulinorésistance (70% des cas)
- Hyperinsulinémie stimule production androgènes
- Cercle vicieux : obésité → IR → hyperandrogénie

Manifestations cliniques

Présentation hétérogène :

- Troubles menstruels : 75-85%
- Hirsutisme : 60-70% (score Ferriman-Gallwey)
- Acné : 15-30%
- Alopécie androgénétique : 5-10%
- Acanthosis nigricans : 5-10%
- Obésité : 40-60% (souvent androïde)

Association SOPK-Hyperprolactinémie

Mécanismes possibles :

- Prévalence : 15-20% des SOPK
- Stress chronique anovulation → ↑ prolactine
- Hyperœstrogénie relative → stimulation lactotropes
- Résistance dopaminergique centrale
- Généralement < 100 ng/mL
- Normalisation possible avec traitement SOPK

Bilan paraclinique

Explorations systématiques :

- Hormonal : LH/FSH, testostérone, DHEA-S
- 17-OH progestérone (exclure HCS)
- TSH, prolactine
- Métabolique : glycémie, insulinémie, HGPO
- Lipidique : cholestérol, TG
- US pelvienne : ≥ 12 follicules 2-9mm ou volume $> 10\text{mL}$

Complications à long terme

Risques multiples :

- Infertilité : 40% (anovulation)
- Diabète gestationnel : RR x3
- Diabète type 2 : 30-40% à 40 ans
- Syndrome métabolique : 40-50%
- Maladies cardiovasculaires : RR x2
- Cancer endomètre : RR x3 (anovulation chronique)
- Apnée du sommeil : 30-50%
- Dépression/anxiété : RR x3

Prise en charge non médicamenteuse

Pierre angulaire du traitement :

- Perte pondérale 5-10% : restaure ovulation 30%
- Régime méditerranéen ou IG bas
- Exercice 150 min/semaine modéré
- Thérapie comportementale
- Gestion stress (yoga, méditation)
- Arrêt tabac si applicable

Traitement médicamenteux

Selon objectifs thérapeutiques :

- Si pas désir grossesse :
 - CO combinés (régularise cycles, ↓ androgènes)
 - Spironolactone 50-200mg/j (anti-androgène)
 - Metformine 1500-2000mg/j (si IR)
- Si désir grossesse :
 - Clomifène citrate 1ère ligne
 - Létrozole (supérieur au CC)
 - Metformine adjuvante
 - Drilling ovarien si échec

Surveillance

Suivi régulier nécessaire :

- Poids, tour de taille tous 6 mois
- TA annuelle
- Glycémie/HbA1c annuelle
- Bilan lipidique tous 2 ans
- Dépistage dépression
- Protection endométriale si aménorrhée > 3 mois
- Échographie pelvienne si saignements anormaux

Messages clés

- SOPK = syndrome hétérogène, diagnostic d'exclusion
- Critères Rotterdam : 2/3 pour diagnostic
- Association fréquente avec syndrome métabolique
- Perte de poids = traitement de première ligne
- Traitement adapté au désir de grossesse
- Risques cardiovasculaires et métaboliques à long terme
- Suivi multidisciplinaire idéal

- Information sur fertilité et options thérapeutiques

Rappels thérapeutiques

- Metformine : débuter 500mg/j, augmenter progressivement
- Spironolactone : 50-100mg/j (CI si grossesse)
- CO combinés : préférer anti-androgéniques
- Clomifène : 50mg J3-J7 du cycle
- Cabergoline : 0.5mg/sem si prolactine élevée

Examens complémentaires

- Test grossesse obligatoire
- Bilan hormonal J3-J5 si possible
- US pelvienne transvaginale
- HGPO 75g si facteurs risque
- IRM hypophysaire si prolactine > 100